

STT-Verordnung

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Sabine Kraus geb.: 18.12.1971 ID: ST-HNO-2026-03
FALL-ID: FALL-HNO-03

Datum der Untersuchung:

28.04.2026

Tumornachsorgekalender-Nr:

ausgestellt am:

28.04.2026

Überweiser:

HNO - Musterklinik

Primärdiagnose:

Primärdiagnose: (Datum)	04/2026
Primärtumor:	C01 - Bösartige Neubildung des Zungengrundes, diagnostiziert 23.04.2026 (aktiv)
Histologie des Primärtumors:	Verhornendes Plattenepithelkarzinom, G2
TNM bei Erstdiagnose:	cT4 cN3b cM0
aktuelle Lokalisation: (z.B. Metastase/Rezidiv)	Zungengrund
TNM-Stadium:	IVB

THERAPIEVERLAUF:

(Zeitraum, Schema + Zyklen bzw. Dosis bei Radiatio)

04/2026 ED und PE: partiell ulzeriertes, mäßig differenziertes (G2), verhornendes invasives Plattenepithelkarzinom der Zunge und des Zungengrundes. 16.04.2026 CT-Staging: ausgedehnte Raumforderung mit subtotal linksbetonter Infiltration der Zungen- und Zungengrundmuskulatur; Verdacht auf Lymphknotenmetastasen. 22.04.2026 Tumorkonferenz Kopf-Hals-Tumore: Empfehlung zur primären Radio(chemo)therapie.

ALLGEMEINANAMNESE:

(Familienanamnese, Risikofaktoren, Vorerkrankungen z. B. Cor/Pulmo, Stoffwechsel, Kollagenosen, Operationen, usw.)

Nikotin: seit Oktober 6 Zigaretten täglich, früher eine Schachtel pro Tag. Alkohol: Wein, ca. 2 Gläser täglich. Allergie: unklare Arzneimittelunverträglichkeit. Sozialanamnese: alleinlebend. Vorerkrankungen: blande.

Allergien: ☒ ja ☐ neinSchrittmacher: ☐ ja ☒ neinPort/PEG: ☒ ja, PEG ☐ neinBetreuung: ☐ ja ☒ nein

TUMORANAMNESE/aktuelle Beschwerden:

Rasche Anschwellung der Raumforderung der Zunge, Dysarthrie und Dysphagie.

Bestrahlungsverordnung

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Sabine Kraus geb.: 18.12.1971 ID: ST-HNO-2026-03
FALL-ID: FALL-HNO-03

AKTUELLER STATUS:

Karnofsky-Index:

50% - regelmäßige medizinische Hilfe und beträchtliche Unterstützung erforderlich. (Karnofsky)

Größe:

154 cm

Gewicht:

42 kg

Ehemals Selbstversorgerin, mittlerweile auf Hilfestellung im Alltag angewiesen; stark eingeschränkt im Umgang mit PEG und Tracheostoma.

BESTRAHLUNGSVERORDNUNG:

Begründung der Strahlentherapie - Indikation:

Versuch der primären Radiochemotherapie: 2-54 Gy auf PT + LAG beidseits; im Anschluss Boost-Aufsättigung bis 72 Gy auf PT + befallene LK.

☒ kurativ☐ palliativ☐ gutartig

Simultane Systemtherapie:

☐ nein; ☒ ja, je nach Verlauf unter RT Versuch Cisplatin weekly 40 mg/m² KOF; bei niedrigem AZ Start angepasst.

Vorbestrahlung ☐ (wann/Lokalisation/Dosis):☒ nein; ☐ ja,

Kontakt SozDienst besprochen/Infoblatt ausgehändigt

☒ ja

ausgebender Arzt:

Dr. Tobias Neumann

auswärtige Bildgebung:

eingelesen: ☐ ja

Bestrahlungsgerät:

☐ L1☐ L2☒ L3☐ AL/IntraBeam

Termine:

Planungs-CT / Maske / Markierung:

30.04.2026 11:30 Uhr

Ersteinstellung:

07.05.2026 10:30 Uhr

Labor vor Chemo:

Tagesklinik:

Station:

Sonstiges:

stationäre Übernahme ab 07.05.2026

Datum: 28.04.2026

erstellender Arzt:

Dr. Alina Vogt

Datum: 28.04.2026

F-/O-Arzt:

Dr. Nils Becker

CT-Anforderung

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Sabine Kraus geb.: 18.12.1971 ID: ST-HNO-2026-03
FALL-ID: FALL-HNO-03

CT-Anordnung vom: 28.04.2026

Anordnender Arzt: Dr. Alina Vogt

DIAGNOSE: Primär C01 - Bösartige Neubildung des Zungengrundes, diagnostiziert 23.04.2026 (aktiv)

Behandlungsindikation:

Zungengrundkarzinom

LAGERUNGS- UND SCANVORGABE: REGION:

☐ Schädel ☒ Hals ☐ Thorax ☐ Abdomen ☐ Becken ☐ 4D-Atemstudie ☐ DIBH

☐ Spezielle Anforderung Region:

☐ bei Erreichen einer GHD von

Gy

☐ am:

☐ Extremitäten:

☐ Ganzkörper-CT:

☐ bitte Arzt hinzurufen

(Soll ein Flap aufgelegt werden, z. B. Basaliom Kopfregion, muss der Flap durch den Ambulanzzarzt VOR dem Planungs-CT aufgelegt werden. Bei Basaliom Nasen-/Ohrregion bitte statt Flap Planungs-CT mit Moulage.)

Lagerung:

☐ Bauchlage	☐ Belly step
☒ Rückenlage	☐ Pro step
☒ Arme: seitlich	☐ Knee step
☒ Maske: Netz IMRT HyperArc	☐ Schultermarker
☐ Nackenschale	☐ Blasenfüllung:
☐ Wing step	☐ Ausmarkierung
☒ Knierolle	☐ Drahtmarkierung:
☐ Bluebag	☐ Vaginaltampon
☐ Zahnschienen	☐ Kopfschale

Datum: 28.04.2026

erstellender Arzt: Dr. Alina Vogt

Datum: 28.04.2026

F-/O-Arzt: Dr. Nils Becker

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Sabine Kraus geb.: 18.12.1971 ID: ST-HNO-2026-03
FALL-ID: FALL-HNO-03

Datum der Untersuchung: 30.04.2026

Gewicht Patient: 42 kg

Ganzkörper-CT: ☐ Patientendurchmesser < 30 cm
☐ Patientendurchmesser > 30 cm (Probeliegen bei Erstgespräch)

Referenzpunkt: Maskenreferenz / Hals

Tischhöhe: 8 cm

LAGERUNG:

☐ Bauchlage	☐ Belly step: A B C
☒ Rückenlage	☐ Pro step
☒ Arme: seitlich	☐ Knee step
☒ Maske: Netz IMRT HyperArc	☐ Schultermarker
☐ Nackenschale	☐ Blasenfüllung:
☐ Wing step; Ring: ja nein	☐ Ausmarkierung
☒ Knierolle	☐ Drahtmarkierung:
☐ Bluebag	☐ Vaginaltampon
☐ Flap/Moulage	☐ Kopfschale
☐ Zahnschienen: oben unten	☐ blaue Matte
☐ Bauchpresse P1 P2 S M L XL	
☐ schiefe Ebene	
☐ DIBH	☐ 4D-Atemstudie
☐ Name Atemkurve:	

Hals-/Kopfmaske mit Netz. PEG und Tracheostoma beachten; Lagerung auf Atem- und Schluckkomfort prüfen.

Nach Durchführung der CT verpflichtende Kontrolle (DA)

kontrolliert:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Wirbelsäule optisch und im Scout gerade gelagert?
Keine metallischen Lagerungshilfen im Bild? | ☒ |
| 2. Ref.-markierung (Bleikugeln) im CT-Schnitt auf einer Schicht? | ☒ |
| 3. Blasen-/Rektumfüllung kontrolliert? | ☐ |
| 4. KM-Reste Darm/Blase -> Arzt dazu | ☐ |
| 5. Ganzer Patientenumfang wird rekonstruiert? | ☒ |
| 6. Bei Kontroll-CT: Was wurde mit Bleikugeln markiert? | ☐ |

Datum: 30.04.2026 11:52

MTRA:

L. Bauer

Datum: 30.04.2026 12:15

F-/O-Arzt:

Dr. Miriam Keller